CODICE 6 — DELLA SALUTE

Versione: V1.6
Allineamento dichiarato: Costituzione V.30; Codice 1 V1.7; Codice 2 V1.5; Codice 3 V1.5; Codice 4 V1.5; Codice 5 V1.4; Codice 7 V1.7; Codice 8 V1.4; C.1-Annex A V1.4; Codice 9 V3.1; Codice 10 V1.5; Codice 11 V1.4; Codice 12 V1.4; Codice 13 V1.5; Codice 14 V1.3; Codice 15 V1.4; Codice 16 V1.4.

TITOLO PRELIMINARE — PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 — Oggetto e natura giuridica

1. Il presente Codice disciplina la tutela della salute quale bene comune infrastrutturale, diritto inviolabile e condizione materiale di esistenza della Confederazione, secondo l'articolo 1.2 della Costituzione.
2. La salute non è una merce, una prestazione a pagamento o un privilegio collegato al possesso di competenze o alla quantità di CBO svolta.
3. Ai fini del presente Codice, per salute si intende il benessere fisico, psichico, relazionale e ambientale della persona. La sua valutazione rispetta l'autodeterminazione individuale e considera le condizioni collettive che incidono sulla salute.
4. Il presente Codice disciplina:
    a) la prevenzione dei rischi connessi al CBO, ai Magazzini e agli habitat;
    b) la sorveglianza sanitaria e il coordinamento con la sicurezza delle mansioni;
    c) la cura primaria, la cura delle persone fragili e la salute mentale;
    d) la gestione degli infortuni e delle malattie professionali;
    e) il Paniere Salute e l'autonomia farmaceutica;
    f) la riservatezza dei dati sanitari.
5. Le competenze del presente Codice si coordinano con quelle dei Codici 12 e 14. Il Consiglio Salute non sostituisce gli organi competenti in materia di sicurezza generale, cura delle persone fragili o protezione dei dati.

Art. 2 — Principi

1. **Prevenzione.** Le attività di CBO, produzione, logistica e apprendimento sono organizzate in modo da prevenire i danni alla salute prima che si verifichino.
2. **Autodeterminazione.** Ogni persona decide sul proprio corpo e sul proprio percorso di cura sulla base di un consenso libero, informato e revocabile. Per i minori e per chi non è in grado di decidere si applica l'articolo 2-ter. Le misure collettive dell'articolo 2-bis possono limitare mansioni, attività e spostamenti nei limiti ivi stabiliti, ma non comprendono mai un trattamento sanitario imposto. Resta salvo l'articolo 8 per la persona temporaneamente incapace in crisi acuta.
3. **Non colpevolizzazione.** Malattia, infortunio e fragilità non costituiscono colpa e non possono comportare, per sé, riduzione del Paniere di Sufficienza, esclusione o sanzione. Si applicano le garanzie del Codice 4.
4. **Prossimità.** La cura è organizzata, per quanto possibile, nel Cerchio, nel Magazzino e nell'habitat della persona. Il ricorso a servizi ospedalieri o centralizzati è disposto quando sia necessario per accedere a competenze di Livello 3 non disponibili localmente.
5. **Non mercificazione del sapere.** È vietato brevettare o assoggettare a paywall il sapere salvavita e la conoscenza sanitaria essenziale. È vietata la rendita derivante dal monopolio di competenze sanitarie, secondo il Codice 5, articolo 8.
6. **Proporzionalità e riservatezza.** Ogni misura sanitaria è limitata allo scopo per cui è adottata. Le

informazioni sanitarie sono trattate solo nella misura necessaria e con le garanzie dell’articolo 11.

Art. 2-bis — Rischio collettivo immediato e coordinamento con l’articolo 8

1. Per **rischio collettivo immediato e documentato** si intende una situazione in cui un agente patogeno, un contaminante o una condizione ambientale, sulla base di evidenze scientifiche verificabili e registrate nel Magazzino del Sapere Salute, comporta un pericolo concreto, attuale e grave di diffusione o danno a terzi, non evitabile con misure meno invasive.

2. L’accertamento è avviato su proposta del Consiglio Salute e richiede:

   a) un dossier che descriva le evidenze, il rischio, le persone o i gruppi potenzialmente esposti e le alternative considerate;

   b) il parere di almeno due persone con competenza di Livello 3, indipendenti e non appartenenti al Cerchio proponente;

   c) la validazione della STV applicabile, quando prevista.

3. Le misure collettive sono deliberate dall’Assemblea Generale secondo la procedura d’urgenza del Codice 3. La deliberazione è motivata e documenta necessità, proporzionalità, durata, alternative meno invasive e criteri di cessazione. Il coordinamento con il Codice 14 si applica quando siano coinvolti profili di sicurezza generale o di interruzione di attività.

3-bis. Le misure collettive possono comprendere esclusivamente:

a) l’informazione pubblica, le raccomandazioni e l’offerta gratuita di test, vaccinazioni, profilassi e DPI, che restano volontari;

b) la protezione indicata dalla deliberazione, tra vaccinazione, profilassi, test e DPI, come condizione per svolgere le mansioni e per frequentare i luoghi a rischio, alle condizioni del comma 3-ter;

c) la sospensione o la riorganizzazione temporanea di attività collettive, riunioni, turni di CBO, mobilità non essenziale e ospitalità non urgente;

d) l’isolamento delle persone contagiose e la quarantena delle persone esposte, alle condizioni del comma 3-quater;

e) le misure su ambienti, acqua, alimenti e beni contaminati e, per le zoonosi, le misure sugli animali ammesse dal Codice 13.

Sono a rischio soltanto le mansioni e i luoghi in cui il contagio può colpire persone particolarmente esposte: i reparti e gli ambulatori, la cura delle persone fragili ai sensi del Codice 12 e, quando il rischio riguarda l’infanzia, gli spazi per l’infanzia e i luoghi di apprendimento collettivo. Nessuno può essere escluso dalle cure di cui ha bisogno né dall’assistenza a una persona ricoverata di cui ha la responsabilità di cura; in questi casi sono adottate precauzioni alternative.

3-ter. Nessuna misura comprende un trattamento sanitario, un prelievo, un test o una vaccinazione eseguiti sul corpo di una persona senza il consenso suo o, per chi non può decidere da sé, di chi decide ai sensi dell’articolo 2-ter. Chi rifiuta la protezione indicata ai sensi del comma 3-bis, lettera b):

a) può essere escluso, per la durata della misura, soltanto dalle mansioni e dai luoghi a rischio;

b) riceve senza ritardo un’altra mansione compatibile, computata nel CBO; se non è disponibile, si applica la sospensione temporanea dell’articolo 11, comma 1, lettera c), del Codice 1. Al minore escluso da uno spazio collettivo sono assicurati la cura e l’apprendimento in altra forma;

c) conserva il Paniere, l’alloggio, le cure, il voto, la partecipazione deliberativa e gli altri diritti, anche durante la misura;

d) non commette illecito; il rifiuto non è annotato né comunicato oltre quanto necessario ad applicare la lettera a).

3-quater. L’isolamento e la quarantena:

a) si svolgono nell’alloggio della persona o, se essa lo preferisce o l’alloggio non lo consente, in uno spazio idoneo messo a disposizione dal Cerchio 1;

b) durano quanto indica il dossier del comma 2 per l’agente in questione e comunque non più di quattordici giorni per persona e per esposizione; una proroga, per non più di altri quattordici giorni, è ammessa soltanto se due persone con competenza L3 attestano che la persona è ancora contagiosa o, per la quarantena, che il periodo di incubazione indicato dal dossier non è concluso. Oltre ventotto giorni l’isolamento della persona ancora contagiosa che non vi acconsente può essere disposto soltanto dal Tribunale di Garanzia, dopo averla ascoltata con le garanzie dell’articolo 25, comma 4, del Codice 4, su attestazione di due persone L3 indipendenti ai sensi del comma 2, lettera b), per periodi non superiori a quattordici giorni e non oltre la durata della misura collettiva; in mancanza si applica soltanto il comma 3-ter;

c) se la persona non vi acconsente, sono disposti individualmente dal Consiglio Salute con atto motivato, comunicato senza ritardo al Tribunale di Garanzia, che li convalida, li modifica o li revoca entro ventiquattro ore ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del Codice 4; in mancanza di convalida cessano. La stessa convalida si applica alla proroga. Non si applica il comma 3 del medesimo articolo;

d) assicurano alla persona la consegna del Paniere, le cure, i contatti a distanza con le persone care, il voto tramite la Rete e la sospensione temporanea del CBO prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera c), del Codice 1, salvo le mansioni che essa chiede di svolgere a distanza;

e) non sono fatti rispettare con la forza, salvo l’intervento del Corpo di Tutela Civica nei limiti dell’articolo 8-ter del Codice 14; la convalida della lettera c) vale anche ai fini del comma 4 di quell’articolo;

f) durante la transizione, se la persona non vi acconsente, sono disposti soltanto dalle autorità sanitarie dello Stato, ai sensi dell’articolo 37 del Codice 4.

3-quinquies. Per tutta la durata della misura il Consiglio Salute proponente pubblica, almeno ogni settimana, il dossier del comma 2, i dati aggregati e anonimi su cui la misura si fonda, il loro andamento e le ragioni di ogni rinnovo o cessazione, nel rispetto dell’articolo 11.

4. La misura:

   a) dura al massimo trenta giorni;

   b) può essere rinnovata solo con una nuova deliberazione e nuova documentazione;

   c) è limitata a quanto strettamente necessario e adotta la misura meno invasiva idonea;

   d) è riesaminata dal Cerchio di Garanzia, su richiesta di qualsiasi membro, entro sette giorni; l’isolamento e la quarantena disposti individualmente seguono invece la convalida del comma 3-quater, lettera c);

   e) è registrata con motivazione, durata e criteri di cessazione, nel rispetto della riservatezza e dei livelli di accesso previsti dai Codici.

5. Quando vengono meno i presupposti, la misura cessa immediatamente. Il rinnovo non può fondarsi sulla sola inerzia o sulla mancata conclusione di un riesame.

6. Il presente articolo disciplina misure di salute pubblica rivolte alla collettività. L’articolo 8 disciplina gli interventi individuali di emergenza sanitaria riguardanti una persona in crisi. I due regimi hanno oggetto, presupposti e procedure distinti e non si cumulano, salvo che siano documentate entrambe le condizioni.

7. Le misure adottate ai sensi del presente articolo non possono ridurre, neppure durante la loro applicazione, il Paniere, l’alloggio, le cure, il voto e la partecipazione deliberativa, né produrre effetti permanenti sull’accesso al CBO o agli altri diritti. Eventuali effetti ulteriori richiedono una procedura autonoma prevista dai Codici competenti e le relative garanzie.

8. Alla cessazione della misura è ripristinata la posizione giuridica precedente della persona. Gli atti necessari a documentare, verificare o sottoporre ad audit la misura possono essere conservati, con accesso limitato e secondo le garanzie di riservatezza dell’articolo 11.

Art. 2-ter — Consenso dei minori e delle persone che non possono decidere

1. Dal compimento del sedicesimo anno la persona presta, rifiuta e revoca da sé il consenso alle proprie cure, ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Se, prima del diciottesimo anno, non è in grado di decidere, si applica il comma 2.
2. Fino al compimento del sedicesimo anno il consenso è prestato da chi ha la responsabilità di cura del minore ai sensi dell'articolo 24.3 della Costituzione, dopo averlo informato e ascoltato in modo adatto all'età. Il parere del minore ha un peso crescente con l'età e la maturità, ai sensi dell'articolo 26.2 della Costituzione. Se le persone responsabili sono più d'una, decidono d'accordo; per le cure urgenti basta il consenso di una di esse. La responsabilità di cura e il consenso del presente comma non vengono meno per la sola cessazione dello status di membro della persona responsabile ai sensi dell'articolo 29, comma 6-bis, del Codice 4. Se nessuno esercita la responsabilità di cura, o nessuna persona responsabile è raggiungibile in tempo utile, il consenso è prestato dal rappresentante temporaneo nominato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del Codice 12, fino alla decisione del Tribunale di Garanzia prevista dal comma 3-bis del medesimo articolo.
3. In caso di disaccordo tra il minore e chi ne ha la responsabilità di cura, o tra più persone responsabili, o di conflitto di interessi tra queste e il minore, possono rivolgersi al Tribunale di Garanzia il minore, ciascuna persona responsabile, il curante o il Consiglio Cura. Il Tribunale acquisisce il parere scritto di una persona con competenza sanitaria L3, indipendente e non coinvolta nella cura, sorteggiata dall'elenco dell'articolo 36, comma 1, lettera b), del Codice 4; ascolta il minore, assistito dalla persona di fiducia prevista dall'articolo 31.5 della Costituzione, e le persone responsabili; decide entro sette giorni o, se la cura non può attendere, entro ventiquattro ore, secondo l'interesse del minore e tenendo conto del suo parere ai sensi del comma 2. Quando l'attesa esporrebbe il minore a un pericolo per la vita o a un danno grave e irreversibile, le cure necessarie sono prestate subito, ai sensi dell'articolo 28.2 della Costituzione, e il Tribunale ne è informato.
4. Le vaccinazioni e le profilassi dei minori seguono i commi da 1 a 3 e non sono mai obbligatorie. Il rifiuto di una vaccinazione non costituisce, da solo, grave negligenza o pregiudizio ai sensi dell'articolo 7-bis del Codice 12. Durante una misura dell'articolo 2-bis il minore che non ha la protezione indicata può essere escluso soltanto dai luoghi a rischio, alle condizioni del comma 3-ter di quell'articolo.
5. Quando una persona adulta non è in grado di decidere sulle proprie cure per una condizione che dura, o che si prevede durerà, oltre sessanta giorni, accertata da due persone con competenza sanitaria L3 indipendenti, il Tribunale di Garanzia nomina un rappresentante stabile, se la persona non lo ha designato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4, del Codice 12. Il rappresentante è scelto secondo l'ordine dell'articolo 7-bis, comma 5, del Codice 12 e decide secondo il comma 6 del medesimo articolo. La persona è informata e ascoltata nella misura in cui può esprimersi. La nomina è riesaminata dal Tribunale almeno ogni dodici mesi e in ogni momento su richiesta della persona, della persona di fiducia, del rappresentante o del Consiglio Cura; cessa quando la persona recupera la capacità. Al disaccordo o al conflitto di interessi tra il rappresentante e la persona si applica il comma 3. Il rappresentante non può acconsentire a misure coercitive, disciplinate soltanto dall'articolo 8.
6. Durante la transizione il presente articolo si applica nei limiti consentiti dalla legge vigente sul consenso dei minori e sulla rappresentanza delle persone incapaci.

CAPO I — ORGANIZZAZIONE, SCHEDE DI SICUREZZA E PREVENZIONE

Art. 3 — Consiglio Salute

1. Ogni Cerchio 1 istituisce un Consiglio Salute composto da tre a sette membri, con competenze di Livello 2 o 3 in ambito sanitario, di cura, agroecologico o di sicurezza sul lavoro. È l'articolazione locale del Cerchio di Competenza Medicina e Salute. I componenti sono sorteggiati secondo l'articolo 12-bis del Codice 3, restano in carica un anno e non possono essere nuovamente sorteggiati nello stesso Consiglio

prima di dodici mesi dalla fine del mandato.

2. Il Consiglio Salute:

   a) gestisce il Magazzino Salute e il Paniere Salute di cui all’articolo 10;

   b) redige e aggiorna, per i profili sanitari di propria competenza, le Schede di Sicurezza delle mansioni CBO;

   c) organizza la sorveglianza sanitaria, la gestione dei DPI di competenza sanitaria e la formazione L1 sulla salute;

   d) registra e analizza infortuni, quasi-infortuni e malattie professionali;

   e) coordina la cura delle persone fragili e gli interventi di salute mentale secondo il Codice 12;

   f) coordina con gli altri Cerchi 1 la gestione delle competenze scarse e delle emergenze vitali, secondo l’articolo 32 del Codice 1 e il Codice 14.

3. Il Consiglio Salute non dispone di poteri allocativi sui beni né di poteri disciplinari. Non può negare o condizionare l’accesso al Paniere.

4. Il Consiglio formula proposte, documenta i rischi sanitari, organizza l’assistenza e svolge le funzioni attribuitegli dal presente Codice. Le sue decisioni sono adottate secondo il metodo del consenso previsto dal Codice 3 e sono tracciate.

5. Per ogni mansione CBO è individuato un referente per la sicurezza con competenza L2, validata secondo il Codice 5. Il referente non sostituisce il Consiglio Salute né il Consiglio Sicurezza previsto dal Codice 14.

Art. 4 — Schede di Sicurezza, DPI e coordinamento con il Codice 2

1. Nessuna attività CBO può essere svolta senza una Scheda di Sicurezza vigente, predisposta secondo le STV applicabili e coordinata con i Codici 1 e 14.

2. Quando una mansione presenta profili sanitari e di sicurezza generale, la Scheda può essere unica e integrata oppure composta da documenti collegati con lo stesso identificativo e la stessa versione. Il Consiglio Salute valida i profili sanitari; il Consiglio Sicurezza valida i profili di sicurezza generale; il Consiglio di Magazzino valida gli aspetti organizzativi di propria competenza. Nessun Consiglio può modificare i parametri attribuiti agli altri.

3. La Scheda contiene almeno:

   a) i rischi specifici;

   b) i DPI e le protezioni collettive necessari;

   c) le procedure operative;

   d) gli errori tipici e le misure per prevenirli;

   e) le condizioni di sospensione;

   f) i riferimenti alle STV applicabili;

   g) i limiti di esposizione e le pause richieste;

   h) la formazione minima necessaria;

   i) la data, la versione, i responsabili e le condizioni di revisione.

4. I DPI sono beni comuni e sono forniti gratuitamente. Sono accessibili, mantenuti efficienti e tracciati dai soggetti competenti per custodia e approvvigionamento. L’assenza di un DPI critico previsto dalla Scheda comporta l’immediata sospensione dell’attività interessata e non costituisce una violazione imputabile alla persona cui il DPI non è stato fornito. L’obbligo di predisporre i DPI spetta al Cerchio responsabile dell’attività.

5. Ogni membro può interrompere un’attività quando rilevi un rischio grave e immediato per sé o per altri. L’interruzione è comunicata appena possibile al responsabile operativo e al Consiglio competente; non può comportare ritorsioni se effettuata in buona fede. Si applicano il Codice 14 e, per la continuità logistica, l’articolo 32, comma 3, del Codice 1.

6. La STV di un bene include i profili di sicurezza sanitaria relativi a produzione, uso, manutenzione e smaltimento. La STV è coordinata con la Scheda di Sicurezza e non la sostituisce quando quest'ultima è richiesta per una specifica mansione.

Art. 5 — Sorveglianza sanitaria, volontarietà e condizioni di sicurezza

1. La sorveglianza sanitaria è volontaria come percorso generale di cura e prevenzione. Per le mansioni individuate ai sensi del comma 2, una valutazione di idoneità può costituire un requisito tecnico per lo svolgimento autonomo di quella specifica mansione; non costituisce un obbligo sanitario generale.
2. Si applicano le seguenti regole:

   a) per le attività CBO a rischio nullo o basso non è richiesta una visita obbligatoria;

   b) per le attività a rischio medio o alto, classificate secondo le STV e la Scheda di Sicurezza, la valutazione di idoneità è richiesta solo quando sia necessaria per la sicurezza della mansione autonoma;

   c) la valutazione di idoneità non è condizione per accedere al Paniere, partecipare alle deliberazioni o appartenere alla Comunità;

   d) chi rifiuta la visita necessaria per una mansione a rischio medio o alto non svolge autonomamente quella specifica mansione, ma conserva il Paniere di Sufficienza, l'accesso agli altri CBO compatibili e il diritto a una mansione alternativa adattata. Il rifiuto non costituisce infrazione e non è registrato come annotazione pregiudizievole;

   e) la visita periodica prevista per una competenza sanitaria L3 ad alto rischio può essere condizione per mantenere la relativa validazione, secondo l'articolo 4, comma 5, del Codice 5. Il rifiuto comporta, se necessario, la sospensione della specifica validazione, non una sanzione.
3. Le valutazioni sanitarie possono comprendere:

   a) una visita iniziale per le mansioni a rischio medio o alto, quando necessaria ai sensi del comma 2;

   b) una visita periodica per le competenze L3, almeno biennale o annuale in caso di esposizione continuativa, secondo le STV applicabili;

   c) una visita richiesta dalla persona in qualsiasi momento;

   d) una visita successiva a un infortunio o a una malattia professionale.
4. Il giudizio è descrittivo e limitato alla mansione interessata. Può indicare:

   a) idoneità;

   b) idoneità con adattamenti;

   c) idoneità con limitazioni temporanee;

   d) sospensione temporanea precauzionale dalla mansione, con mantenimento del Paniere e proposta di un CBO alternativo.
5. L'inidoneità definitiva a una specifica mansione può essere pronunciata esclusivamente da un Collegio di Riesame esterno secondo le garanzie del Codice 4, articolo 17. Il Collegio è composto da:

   a) una persona con competenza sanitaria L3, sorteggiata e non appartenente al Cerchio della persona interessata;

   b) una persona del Consiglio Qualità non coinvolta nel procedimento;

   c) una persona sorteggiata tra i membri dell'Assemblea di un Cerchio 1 diverso da quello interessato, con funzione di garanzia procedurale.
6. Prima della decisione, il Collegio acquisisce il parere scritto di due persone con competenza sanitaria L3 indipendenti, non coinvolte nei precedenti giudizi e, ove pertinente, con specializzazioni diverse. Le persone che esprimono il parere non fanno parte del Collegio e non partecipano alla decisione.
7. Nessun componente del Collegio può avere espresso un precedente giudizio di idoneità sulla medesima persona e mansione. I pareri sono messi a disposizione della persona interessata prima della decisione, salvo le limitazioni strettamente necessarie per proteggere dati sanitari di terzi.

8. La decisione è motivata e tracciata. Contro l’inidoneità definitiva è ammesso ricorso entro quattordici giorni a un nuovo Collegio esterno, composto da persone diverse. Il ricorso è ammesso per:
    a) vizio procedurale;
    b) manifesta irragionevolezza tecnica;
    c) discriminazione;
    d) manifesta sproporzione.

Si applicano il Codice 4, articolo 17, e il Codice 5, articolo 9. Il Collegio di secondo grado non può aggravare la posizione del ricorrente.

9. Durante la procedura di accertamento dell’inidoneità definitiva, la persona conserva il Paniere di Sufficienza e riceve una proposta di CBO alternativo compatibile.

10. Nessun dato sanitario può essere usato per limitare l’accesso alle deliberazioni, al Paniere o all’apprendimento.

CAPO II — CURA, FRAGILITÀ E SALUTE MENTALE

Art. 6 — Cura primaria e Magazzino Salute

1. Ogni Magazzino dispone di un Magazzino Salute e di un Paniere Salute minimo, definiti dal Consiglio Salute federato secondo le competenze dei Codici. Il Paniere comprende almeno:
    a) farmaci essenziali salvavita;
    b) materiale di primo soccorso;
    c) DPI di competenza sanitaria;
    d) strumenti diagnostici di base;
    e) documentazione e STV sanitarie validate.
2. La cura primaria è organizzata mediante affiancamento e ambulatori di Cerchio, con il coinvolgimento di competenze L2 e L3. La persona sceglie tra le competenze disponibili, anche appartenenti ad altri Cerchi.
3. L’IA prevista dal Codice 7 può supportare l’indicizzazione dei protocolli, la ricerca di informazioni e i promemoria. Non può formulare autonomamente diagnosi, determinare l’idoneità o decidere il trattamento.
4. Quando una competenza non è disponibile localmente, il Consiglio Salute attiva la rete tra Cerchi e il Registro Dipendenze previsto dal Codice 15. Le misure possibili comprendono:
    a) l’invio della persona al servizio competente;
    b) l’invio temporaneo della competenza al Cerchio interessato;
    c) il tele-affiancamento supervisionato da una persona L3, quando appropriato e sicuro.
5. La modalità scelta rispetta la volontà della persona, la riservatezza sanitaria e la continuità della cura.
6. La tutela della salute si articola nei tre livelli integrati dell’articolo 28.1 della Costituzione: l’IA personale offline con funzione preventiva, secondo l’articolo 5-bis del Codice 7; i curanti della Comunità di Base; i centri di alta specializzazione del Cerchio 3.

Art. 7 — Fragilità, interdipendenza e cura

1. Anziani, bambini, persone con disabilità, persone con malattie croniche, persone in gravidanza o nel periodo successivo al parto, persone in lutto o in situazione di crisi hanno diritto a una tutela rafforzata e, quando necessario, alla modulazione del CBO ai sensi dell’articolo 11 del Codice 1 e del Codice 12.
2. La cura delle persone fragili rientra nel CBO di Lista A ed è collocata al livello 4 della gerarchia di priorità dell’articolo 32 del Codice 1.

3. Le attività di cura non possono essere differite per carenza logistica, salvo che debbano essere gestite emergenze vitali di livello 1 o 2. La decisione di differimento è motivata e deve prevedere, ove possibile, una misura sostitutiva.
4. Ogni Piano CBO include una quota di cura e affiancamento. La cura non è considerata un'attività residuale da svolgere solo dopo aver soddisfatto gli altri fabbisogni.
5. La modulazione del CBO non comporta riduzione del Paniere di Sufficienza né annotazioni pregiudizievoli.

Art. 8 — Salute mentale e protocollo per la crisi acuta

1. La salute mentale è parte integrante della salute. Distress, burnout, conflitto e trauma non costituiscono colpa o debolezza individuale.
2. Il Consiglio Salute garantisce, direttamente o mediante il coordinamento con il Codice 12:
    a) spazi di ascolto;
    b) gruppi di parola;
    c) affiancamento psicologico L2 o L3;
    d) riduzione temporanea del carico CBO, quando necessaria;
    e) supporto tra pari;
    f) accesso a competenze specialistiche senza lista d'attesa interna ingiustificata.
3. In caso di crisi acuta si applica, come regola, un protocollo di protezione non coercitivo, basato su:
    a) presenza e ascolto;
    b) messa in sicurezza relazionale e ambientale;
    c) proposta di supporto;
    d) coinvolgimento, se desiderato dalla persona, di una persona di fiducia da lei designata.
4. Una misura coercitiva immediata è ammessa solo se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
    a) esiste un rischio vitale immediato e concreto per la persona o per terzi, documentato al momento da due persone con competenza L3, almeno una delle quali sanitaria;
    b) la persona è temporaneamente incapace di esprimere un consenso valido;
    c) non esiste, nell'immediato, una misura meno invasiva ugualmente efficace.
5. Ove le due competenze L3 non siano immediatamente disponibili, sono attivate senza ritardo le procedure di reperimento federato o di tele-affiancamento previste dall'articolo 13 del Codice 15. Nell'attesa sono ammesse esclusivamente misure non coercitive necessarie alla messa in sicurezza immediata.
6. L'intervento coercitivo eventualmente adottato:
    a) è limitato al tempo strettamente necessario a scongiurare il rischio vitale;
    b) è effettuato con presenza di due persone L3, quando immediatamente disponibili;
    c) è comunicato senza ritardo al Tribunale di Garanzia per la convalida del comma 7 e al Cerchio di Garanzia;
    d) è documentato in Rete con accesso regolato;
    e) è comunicato alla persona di fiducia designata, quando possibile;
    f) cessa immediatamente quando vengono meno i presupposti.
7. Entro ventiquattro ore dall'inizio della misura il Tribunale di Garanzia, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice 4, la convalida, la modifica o la revoca. Verifica i presupposti del comma 4, la necessità e la proporzionalità sulla base della documentazione delle due persone L3 e, quando possibile, dopo aver sentito la persona, il suo rappresentante e la persona di fiducia. Non svolge una valutazione clinica, che resta di competenza delle persone sanitarie L3. In mancanza di convalida nel termine la misura cessa. Se interviene il Corpo di Tutela Civica, la convalida del presente comma tiene luogo di quella prevista

dall’articolo 8-ter, comma 4, del Codice 14.

8. Dopo la crisi è proposto alla persona un percorso di cura volontario.

9. Sono sempre vietati la contenzione punitiva, l’isolamento usato come sanzione e la sedazione punitiva.

10. La misura coercitiva:

    a) è rivalutata dalle due persone L3 almeno ogni dodici ore e, durante la contenzione fisica, almeno ogni ora; ogni rivalutazione è documentata;

    b) dopo la convalida dura al massimo settantadue ore e può essere prorogata soltanto con una nuova convalida del Tribunale di Garanzia, chiesta prima della scadenza sulla base di una nuova attestazione di due persone L3, per periodi non superiori a settantadue ore; in mancanza di nuova convalida prima della scadenza la misura cessa;

    c) non può superare complessivamente quattordici giorni. Alla scadenza la misura cessa anche se il rischio persiste; sono assicurati senza interruzione la presenza continuativa di persone formate, la messa in sicurezza relazionale e ambientale del comma 3 e l’offerta di cure, e la persona può restare volontariamente nel luogo di cura. Una nuova misura coercitiva è ammessa soltanto per un nuovo episodio acuto, alle condizioni del comma 4 attestate da due persone L3 diverse da quelle che hanno attestato la misura precedente, e con la convalida di un Tribunale di Garanzia in diversa composizione, che verifica espressamente che non si tratta della prosecuzione della misura cessata. Nell’arco di novanta giorni le misure coercitive non possono superare complessivamente ventotto giorni;

    d) è revocata in ogni momento dal Tribunale di Garanzia, quando ne vengono meno i presupposti, su richiesta della persona, del suo rappresentante o della persona di fiducia; la richiesta è decisa entro ventiquattro ore.

Il rappresentante non può acconsentire a una misura coercitiva in luogo della persona: si applica soltanto il presente articolo. Durante la transizione non sono eseguite misure coercitive interne; ogni intervento è limitato a quanto consentito dalla legge vigente e sono allertati i servizi di emergenza e le autorità sanitarie competenti, ai sensi dell’articolo 37 del Codice 4.

11. È vietato inserire etichette stigmatizzanti nel Portfolio Personale.

Art. 8-bis — Testamento biologico e fine vita

1. Il testamento biologico è vincolante, ai sensi dell’articolo 27.3 della Costituzione. È redatto dalla persona, con l’eventuale assistenza della propria IA personale offline e alla presenza di due testimoni; è custodito nel Nodo personale e, se la persona lo desidera, presso il Consiglio Salute in forma riservata. È revocabile e modificabile in ogni momento.

2. Con il testamento biologico la persona può designare il proprio rappresentante per il caso di incapacità, ai sensi dell’articolo 7-bis del Codice 12.

3. Nessuno può essere sottoposto contro la propria volontà ad accanimento terapeutico. Le cure palliative e il sollievo dal dolore fanno parte del Paniere Salute.

4. È garantito il diritto al domicilio, con il supporto comunitario a turni previsto dal Codice 12. Le Case Comuni autogestite sono una scelta della persona e non possono costituire una destinazione coatta.

CAPO III — INFORTUNI, FARMACI, RISERVATEZZA E AUTONOMIA

Art. 9 — Infortuni, quasi-infortuni e malattie professionali

1. Ogni infortunio, quasi-infortunio o sospetta malattia professionale è segnalato e registrato senza ritardo. Il registro operativo contiene solo le informazioni necessarie all’analisi dell’evento, tra cui:

    a) descrizione dell’accaduto;

    b) mansione svolta;

c) Scheda di Sicurezza applicabile;

d) DPI e protezioni disponibili;

e) condizioni operative pertinenti;

f) data e ora dell'evento.

2. I dati identificativi e sanitari sono conservati separatamente e con accesso riservato secondo gli articoli 7 del Codice 14 e 11 del presente Codice. Le informazioni pubblicate sono aggregate e anonimizzate.
3. L'analisi distingue, senza presumere automaticamente una responsabilità individuale:

   a) usura o caso fortuito, che comportano la revisione delle STV e dell'organizzazione, senza responsabilità individuale automatica;

   b) carenze organizzative, che richiedono la revisione delle misure da parte del Cerchio responsabile e del Consiglio Salute;

   c) condotte dolose o altre condotte individuali rilevanti, che sono trattate secondo il Codice 4.
4. La persona infortunata ha diritto alla cura, al mantenimento del Paniere e, durante la convalescenza, alla proposta di un CBO alternativo adattato, quando compatibile con la sua condizione.
5. Il Consiglio Salute federato svolge almeno trimestralmente un'analisi aggregata degli infortuni e dei quasi-infortuni per proporre l'aggiornamento delle STV del Codice 2 e delle Schede di Sicurezza.
6. Il ciclo di prevenzione comprende: registrazione dell'evento, analisi delle cause, aggiornamento delle misure, revisione delle STV e prevenzione di eventi futuri.

Art. 10 — Paniere Salute, farmaci, fitoterapia e sperimentazione

1. Il Paniere Salute costituisce parte del Paniere di Sufficienza previsto dal Codice 1. Comprende beni salvavita la cui indisponibilità può determinare un'emergenza vitale di livello 1.
2. La Confederazione persegue l'autonomia nella produzione o nell'approvvigionamento federato di farmaci essenziali non brevettati e dispositivi riutilizzabili, secondo le STV del Codice 2. Le dipendenze critiche da fornitori esterni sono registrate nel Registro Dipendenze previsto dal Codice 15.
3. Per **fitoterapia validata** si intende un preparato vegetale corredato da una STV vigente che indichi almeno:

   a) la specie e la parte utilizzata;

   b) il dosaggio;

   c) le indicazioni e le controindicazioni;

   d) le interazioni note;

   e) le evidenze disponibili e i relativi limiti;

   f) le modalità di preparazione e conservazione.

L'uso tradizionale, da solo, non costituisce validazione. Ogni preparato validato è registrato nel Registro STV Salute.

4. È vietata la dipendenza proprietaria critica da cui dipendano farmaci salvavita, dispositivi diagnostici essenziali o DPI. Si applicano gli articoli 4 e 5 del Codice 2 e le disposizioni del Codice 15.
5. Nessuna sperimentazione sanitaria può essere svolta su membri senza consenso libero, informato, specifico e revocabile. Il consenso è documentato per iscritto dopo aver fornito informazioni comprensibili su rischi, benefici, alternative e diritto di recesso.
6. La sperimentazione richiede preventivamente:

   a) l'approvazione di un Collegio esterno sorteggiato secondo il Codice 4, articolo 17, composto da tre persone con competenza sanitaria L3 non coinvolte nella sperimentazione;

   b) il parere del Cerchio di Garanzia sul consenso e sulla proporzionalità;

   c) la deliberazione dell'Assemblea Generale secondo il Codice 3.

7. È vietata la sperimentazione su minori, persone in crisi acuta ai sensi dell’articolo 8 o persone temporaneamente prive della capacità di esprimere il consenso, salvo il caso eccezionale in cui sia diretta a conseguire un beneficio diretto e specifico per la persona stessa. In tale caso devono ricorrere cumulativamente tutte le condizioni seguenti:

    a) consenso prestato secondo l’articolo 2-ter: per il minore, da lui stesso se ha compiuto sedici anni, altrimenti da chi ne ha la responsabilità di cura; per la persona incapace, dal rappresentante designato o nominato ai sensi dell’articolo 7-bis del Codice 12 o dell’articolo 2-ter, comma 5. La persona di fiducia non è considerata rappresentante, salvo che sia stata formalmente designata a tale funzione;

    b) se il rappresentante non è disponibile, applicazione della procedura urgente prevista dall’articolo 7-bis del Codice 12 per la persona temporaneamente incapace, inclusa la nomina urgente di un rappresentante da parte dell’organo competente;

    c) parere conforme scritto di due persone L3 indipendenti e non coinvolte, attestante il beneficio diretto, l’assenza di alternative di efficacia comparabile e la proporzionalità del rischio;

    d) autorizzazione del Cerchio di Garanzia sui profili di consenso e proporzionalità;

    e) deliberazione dell’Assemblea Generale secondo il Codice 3, con maggioranza qualificata e tracciamento delle posizioni espresse;

    f) ascolto e rispetto della volontà della persona nella misura in cui sia in grado di esprimerla.

La mancanza di una sola delle condizioni impedisce l’avvio della sperimentazione.

8. Ogni sperimentazione deve prevedere tracciamento, copertura delle responsabilità collettive, accesso alla cura per eventuali conseguenze e diritto di recesso immediato senza pregiudizio.
9. La violazione dei commi da 5 a 8 costituisce vizio procedurale grave e comporta l’applicazione del Codice 4, compresi gli effetti di invalidità e gli obblighi di riparazione.

Art. 11 — Riservatezza sanitaria e separazione dei dati

1. La persona cui il dato sanitario si riferisce ne mantiene il controllo. Il Sistema fiduciario del Cerchio svolge funzioni di custodia e gestione tecnica, senza poter utilizzare i dati per finalità proprie o incompatibili.
2. L’accesso ai dati sanitari è regolato come segue:

    a) l’accesso ordinario spetta alla persona interessata e alla persona di fiducia da essa designata, nei limiti del consenso;

    b) il Consiglio Salute può accedere alle informazioni necessarie alla sorveglianza sanitaria, limitandosi, di norma, ai giudizi di idoneità e agli adattamenti e non alle diagnosi dettagliate;

    c) il Cerchio di Garanzia può accedere ai dati necessari per decidere un ricorso, secondo una procedura tracciata e con accesso limitato;

    d) in assenza di consenso, l’accesso del Consiglio Salute è ammesso solo quando sia necessario a dare esecuzione a una misura collettiva validamente deliberata ai sensi dell’articolo 2-bis. L’accesso è limitato ai dati strettamente necessari, proporzionato e temporaneo, è tracciato e, quando possibile, comunicato alla persona interessata. È ammesso il riesame del Cerchio di Garanzia entro sette giorni.
3. Il Magazzino del Sapere contiene esclusivamente:

    a) Schede di Sicurezza prive di dati sanitari individuali;

    b) STV sanitarie anonimizzate;

    c) statistiche aggregate sugli infortuni;

    d) protocolli di cura validati.

Non contiene dati sanitari individuali.

4. È vietata la pubblicazione di dati sanitari nominativi, elenchi di patologie riferibili a persone o mappe

individuali di fragilità. La violazione costituisce vizio procedurale grave secondo il Codice 4.

5. Ogni persona ha diritto:

   a) di ottenere copia dei propri dati sanitari;

   b) di chiederne la rettifica;

   c) di chiederne la cancellazione quando non siano più pertinenti o necessari;

   d) di chiedere la cancellazione o l’oblio di episodi superati, salvo le misure collettive documentate e validamente deliberate ai sensi dell’articolo 2-bis, limitatamente alle informazioni strettamente necessarie.

6. La cancellazione o rettifica del dato personale non comporta la cancellazione di informazioni già rese irreversibilmente anonime e utilizzate per statistiche, analisi epidemiologiche o aggiornamento delle STV. I dati personali sono tenuti distinti dai dati statistici anonimi e non devono poter essere ricostruiti.

Art. 12 — Disposizioni transitorie e collegamenti

1. Il presente Codice si coordina con:

   a) Codice 1, articoli 27, 29, 31 e 32;

   b) Codice 2, per le STV e la validazione dei beni;

   c) Codice 3, per le procedure d’urgenza e le deliberazioni;

   d) Codice 4, articolo 17, per il Collegio di Riesame e le garanzie;

   e) Codice 5, per le competenze L2 e L3, l’articolo 4, comma 2, lettera c), l’articolo 4, comma 5, e l’articolo 10;

   f) Codice 12, per la cura delle persone fragili;

   g) Codice 14, per la sicurezza generale;

   h) Codice 15, per il Registro Dipendenze.

2. Si applica la validazione provvisoria sanitaria prevista dall’articolo 10 del Codice 5. Chi esercita una funzione sanitaria ad alto rischio alla data di entrata in vigore può mantenere una validazione provvisoria:

   a) per sei mesi per le funzioni corrispondenti al Livello 3 del Codice 5;

   b) per dodici mesi per le funzioni corrispondenti al Livello 2 del Codice 5.

Sono richiesti l’iscrizione al percorso di validazione entro trenta giorni, la supervisione rafforzata, il rispetto delle STV e la tracciabilità delle attività. Durante il periodo provvisorio la persona non può validare le competenze di altri.

3. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore, ogni Cerchio 1 attiva un Magazzino Salute minimo e predispone le Schede di Sicurezza per le mansioni sanitarie e di sicurezza sanitaria classificate L3 e attive, secondo il Codice 5, articolo 4, comma 2, lettera c).

4. Per le mansioni L3 non sanitarie si applicano il Codice 5 e il Codice 14; il presente Codice non ne disciplina la validazione tecnica.

5. Entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore è svolto un audit federato sull’autonomia farmaceutica e sui DPI, con registrazione delle dipendenze critiche nel Registro Dipendenze del Codice 15.